

«Інфекційний ендокардит»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:
 - продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
 - спитати скарги та деталізувати їх;
 - вияснити анамнез захворювання та життя;
 - продемонструвати практичну навичку “Аускультация серця”;
 - виділити провідний синдром;
 - провести розмову з пацієнтом щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 - продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

1. Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження хворого з діагнозом інфекційний ендокардит».

2 Додаток 1. Об’єктивне обстеження.

Стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком. Периферійні набряки стоп і гомілок. В легенях:– везикулярне дихання, ЧДР – 26/хв. Серце: ліва межа – 5 м/р по лівій середньоключичній лінії, права – 2,5см назовні від правого краю грудини. АТ на обох руках - 110/70 мм.рт.ст, ЧСС=Ps= 110 /хв. Живіт м’який, безболісний. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2-3 см, селезінка + 2-3 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу	Дуже приємно.

	обстеження.	
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Юлія Вікторівна
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	46 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я інженер.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Юліє Вікторівно, що Вас турбує?	Задихаюсь, слабкість у мене, дуже потію вночі, ноги набряклі, підвищення температура тіла.
	Опишіть будь ласка задишку, Вам важко вдихнути чи видихнути? Коли вона виникає?	Мені не вистачає повітря, я задихаюсь, особливо коли прибираю в хаті.
	Юліє Вікторівно, до яких цифр підвищується температура? Як давно?	37,4-37,7 ⁰ С. Біля 3 тижнів.
	Біль в ділянці серця ?	Немає.
	Перебої в роботі серця не відчуваєте?	Дуже часто відчуваю серцебиття.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Коли Ви захворіли?	Місяць тому.
	Розкажіть будь ласка з чого все почалося?	Я видалила зуб місяць тому, після чого у мене з'явилась температура 38,9 ⁰ С, головний біль, слабкість. Лікувалась самостійно, приймала парацетамол. Мені стало краще, знизилась температура тіла до 37,2 ⁰ С, а десь через 3 тижні з'явилась задишка, помітила набряки на ногах

		і наростаючу слабкість.
	Ви до лікаря звертались за допомогою?	Ні
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Останній тиждень не можу ходити через задишку, набряки на ногах збільшились.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, бронхіт, дефект міжшлуночкової перетинки.
	Ви перебуваєте на обліку у кардіолога з Вашою вадою серця?	Так, з дитинства знаходжусь на обліку у кардіолога. Ліків не призначали мені, тільки спостерігають. Кажуть все добре.
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?	Ні
	Операції, травми протягом життя?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків? Шкідливі звички?	Ні
	Спадковість: хтось хворів захворюваннями серця?	Ні
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Юліє Вікторівно, зараз я Вам проведу аускультацию серця, будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		

Провести аускультацию серця	Пальпаторно визначити місце верхівкового поштовху	
	Аускультация серця в коректній послідовності: - перша точка - над верхівкою серця - друга точка - II міжребер'я справа від груднини - третя точка - II міжребер'я зліва від груднини - четверта точка - біля основи мечоподібного відростка груднини - п'ята точка – 4 міжребер'я зліва від груднини	
	Визначити характеристику серцевих тонів: Тони серця ритмічні, приглушені, грубий систолічний шум у 4 точці аускультатії, акцент 2 тону над легеневою артерією.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Як Ви себе почуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так. Добре.
	Юліє Вікторівно, на жаль у Вас є проблеми з серцем, треба подальше дообстеження в стаціонарі, встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	Зрозуміла.
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – синдром серцевої недостатності.	
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Хочу наголосити на тому, що крім регулярного прийому ліків,	Дякую, лікарю.

	Вам показаний охоронний режим до 6 місяців, потрібно обмежити сіль і рідину, фізичні навантаження, перегрівання, переохолодження і перебування у вологих приміщеннях.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Юліє Вікторівно, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозуміла
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.